

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 子宮肌瘤<br>Uterine Myoma |     |        |      |                 |
|--------|-----------------------|-----|--------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q03-W-M01      | 制定者 | R9 黃麗華 | 公布日期 | 97 年 05 月 31 日  |
| 制定單位   | 護理部                   | 核准者 | 吳姿蓉    | 修正日期 | 114 年 10 月 08 日 |
| 版本/總頁數 | 第 3.9 版/13 頁          | 審查者 | 曾翊鍵    | 檢閱日期 | 114 年 10 月 08 日 |

## 一、目的

讓護理人員了解子宮肌瘤的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

## 三、說明

### （一）定義

子宮肌瘤是一種平滑肌瘤(Leiomyomas)或纖維瘤(Fibromyomas)，也是一種最常發生於骨盆腔、良性且生長慢的實心腫瘤，在未停經女性之發生率約為 20~30%，子宮肌瘤是生育年齡婦女中最常見的婦女疾病，依據不同的解像能力的儀器檢查，據估計約有 40~80%的育齡婦女，在常規檢查中，可能被檢查出有子宮肌瘤的診斷，40~50 歲是發生率最高的年齡層，有家族遺傳趨勢，產生原因尚未明，但與賀爾蒙不平衡有關。

### （二）症狀

- 1.經血量過多：每個月月經來潮時，由於子宮肌瘤之故，讓子宮內膜出血面增加，且會干擾子宮收縮而導致經血量增多。多數罹患子宮肌瘤的女性常因經血量過多而有貧血情形。
- 2.壓迫症狀：若腫瘤很大，則會壓迫到附近的臟器，如壓迫到膀胱會造成膀胱功能障礙，導致排尿次數增加、壓力性尿失禁和尿瀦留等；若壓迫直腸則會造成排便困難。另外亦有可能會因腫瘤壓迫而阻塞骨盆腔的血液及淋巴液循環，造

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 子宮肌瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-M01 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 2/13 |

成下肢及足踝水腫、靜脈曲張和痔瘡等。

- 3.疼痛：子宮肌瘤很少會造成疼痛，而引發疼痛的情形可能有肌瘤上蒂狀發生扭轉、子宮肌瘤突出於子宮頸，或是有惡性的病變等因素。
- 4.妊娠併發症：懷孕時，較大的肌瘤會引發習慣性流產或早產。若肌瘤靠近子宮頸口，生產時會阻礙產道造成難產或是產後出血，故需行剖腹生產。

### （三）常見檢查

- 1.超音波檢查(Ultrasonography)：為第一線的診斷工具，可偵測出體內腫瘤的位置。能早期發現子宮、卵巢或膀胱等器官病變。腹部超音波檢查需於檢查前先漲尿有助顯像；陰道超音波檢查則於檢查前排空膀胱。
- 2.骨盆腔檢查(Pelvic Examination)和陰道直腸指診(vaginal-rectal examination)：檢查腹部是否有硬塊及大小、子宮是否有脫垂及程度、子宮頸外觀、陰道內部、出血、陰道後穹隆或直腸有無異常。檢查後需注意內診後陰道可能會有少量出血或分泌物，應協助使用棉墊。

### （四）常見治療

- 1.藥物治療：年輕個案有子宮肌瘤及非功能性出血時，若其症狀輕微可合併使用雌性素及黃體素來治療，約每天服用 2-3 次，連續服用 3-6 個月。
- 2.手術治療：
  - (1) 肌瘤切除術(Myomectomy)：一般 40 歲以下想保留生育能力的女性可行肌瘤切除術，僅將子宮壁上的肌瘤切除，保有子宮。手術缺點是有許多如小種子樣大小的肌瘤，因肉眼看不到而會被忽略，約 1/4 的個案會復發。故應儘可能早點懷孕，否則肌瘤復發的可能性極高。手術後下腹部有一橫式的傷口，約 10-15 公分，無需拆線。
  - (2) 全子宮切除術(Total hysterectomy, TAH)：40 歲以上不想再生育的女性，或是肌瘤太大，為了預防肌瘤再度復發，故切除子宮是治療子宮肌瘤及防止復發的最佳方法。手術後下腹部有一橫式或直式的傷口，約 10-15 公分。橫式傷口無需拆線；直式傷口因外層採釘子固定，故需拆釘，一般視傷口

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 子宮肌瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-M01 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 3/13 |

癒合情況約手術後 5-7 天拆半釘，另一半釘通常於隔天或數天後回門診再拆。

- (3) 經陰道子宮切除(Vaginal hysterectomy, VH)：40 歲以上不想再生育的女性，或是肌瘤太大，為了預防肌瘤再度復發，故切除子宮是治療子宮肌瘤及防止復發的最佳方法。手術後無傷口，陰道會塞紗布以加壓止血，隔天由醫師移除，需注意陰道出血量。
- (4) 經子宮頸之子宮內視鏡切除(Transcervical resectoscopy, TCR)：子宮肌瘤生長在子宮頸處，因此僅將子宮頸處的肌瘤切除即可。手術後傷口小且出血量少，一般此手術無需住院，陰道會塞紗布以加壓止血，當天晚上洗澡前自行移除，需注意陰道出血量。
- (5) 腹腔鏡(vedio/lapascopy)：年輕、未婚、無性行為、已婚未生育或是想生育、想保留子宮、未達更年期、肌瘤小的女性可行腹腔鏡術。手術優點有手術後傷口小、復原較迅速、縮短住院日。手術方法在肚臍下緣及下腹部處開 2-4 個約 1-2 公分的小洞，打入二氧化碳，將肚子鼓脹起來，再放入腹腔鏡儀器清除病灶。手術中有可能會在腹部放置 1 條引流管，引流腹內血水，一般引流液量約 <50ml/天可依醫囑移除之。手術後腹部有 2-4 個約 1-2 公分傷口，需拆線，通常於出院後第一次回診拆線。
- (6) 腹腔鏡經陰道行子宮切除(Laparoscopy asist vaginal hysterectomy； LAVH)：40 歲以上不想再生育，或是接近更年期的女性可行腹腔鏡經陰道行子宮切除術。手術優點有手術後傷口小、復原較迅速、縮短住院日。手術方法及手術後同上，陰道會塞紗布以加壓止血，隔天由醫師移除，需注意陰道出血量。
- (7) 達文西手術：如同腹腔鏡手術。微創手術是目前婦科手術的趨勢，優點為恢復迅速、美觀及疼痛程度較為輕微。達文西手術系統是利用精密機器手臂平台進行微創手術，統由三個主要元件構成，包括 1.手術控制台：手術醫師藉由主控器控制 3D 內視鏡及內視鏡器械、2.手術車台：主要的功能是支撐器

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 子宮肌瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-M01 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 4/13 |

械手臂和攝影機手臂，利用遠端中心技術，透過內視鏡及器械操作進行手術，當內視鏡啟動時就可提供連續的 3D 手術視野、3.影像車台：中央處理系統及圖像設備。內視鏡器械可以進行抓持、切割、剝離、電燒、縫合等精確控制，同時具有如同開放性手術的靈活性，並將正常人不自主手震動或無意識視線轉移的影響降到最低。

(8) 海扶刀療法(HIFU, High-intensity Focused Ultra-sound)：有效率約 95%的「免開刀子宮肌瘤無創治療」，是目前全球最新子宮肌瘤治療方法。海扶刀無創治療是透過超音波聚焦原理，無傷口、無放射線、免麻醉、無沾黏、不流血、不受腫瘤大小、形狀限制、治療時間短、恢復期快、保留子宮及功能，治療過程不損傷正常子宮組織，消融治療所產生的壞死組織可被正常組織逐漸吸收，使子宮肌瘤變小，達到減輕或緩解相應症狀。一般情況採取一次性大範圍治療，術後恢復快，對於巨大或數量高達 10 顆以上子宮肌瘤，可重複治療，也可計畫性分段治療。

#### (五) 護理問題

1. 焦慮感受/與對於健康的威脅、缺乏有關於疾病及治療的相關知識有關。
2. 疼痛不適/與疾病引起的疼痛、手術後傷口疼痛有關。
3. 易感染/與手術後傷口、引流管留存有關。
4. 身體心像不一致/與子宮切除導致身體完整性受損有關。
5. 性生活型態失常/與子宮切除術後有關。

#### (六) 護理措施

1. 焦慮感受/與對於健康的威脅、缺乏有關於疾病及治療的相關知識有關
  - (1) 評估個案焦慮程度及主要原因。
  - (2) 鼓勵及引導個案說出心中的感受和想法，以及目前不適的症狀，並給予適當的醫療處置及護理。
  - (3) 運用同理心，耐心地傾聽個案心中的感受和想法，尋找引起焦慮的原因。
  - (4) 主動提供正確的疾病及治療的相關資訊給個案，適時地澄清及修正其錯誤

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 子宮肌瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-M01 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 5/13 |

的觀念，以減輕個案的焦慮感。

- (5) 執行醫療處置或護理照護前，應給予詳細解釋其準備工作及注意事項，並提供衛教單張閱讀，以減輕個案的不安感。
- (6) 執行醫療處置或護理照護時，應注重個案之隱私，勿過度裸露個案身體隱私部位，必要時用屏風遮擋，請異性回避。男性醫師幫女性個案做婦科檢查時，女性護理人員應要陪同在旁。
- (7) 利用行為或認知策略，教導個案規律的呼吸、放鬆的技巧（如按摩）、冥想等，以減輕焦慮。
- (8) 轉移個案注意力，如聽音樂、聊天。
- (9) 教導個案手術後咳嗽、翻身、下床活動時，如何固定傷口，減少傷口疼痛，且會依當時疼痛程度給予控制疼痛的處置，以減輕個案害怕傷口疼痛之焦慮。
- (10) 讓個案瞭解手術後可能存在的管子及其重要性，以減少焦慮。
- (11) 介紹相同的個案，彼此經驗分享。
- (12) 多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減少焦慮。
- (13) 隨時評估個案焦慮改善狀態。
- (14) 若個案焦慮感持續無法改善，必要時依醫囑給予藥物治療，如：鎮靜、神經安定劑。

## 2. 疼痛不適/與疾病引起的疼痛、手術後傷口疼痛有關

- (1) 評估個案的疼痛部位、程度（0 不痛～10 最痛）、頻率（間歇、持續）、發作時間、持續時間及特徵（刺痛或拍動痛、深沈或表淺），並記錄疼痛的變化。
- (2) 監測生命徵象的變化，如：疼痛時，血壓上升，心跳、呼吸次數增加。
- (3) 與個案或家屬確認引發疼痛的因素，如個人的、與疾病有關的、與治療有關的。
- (4) 與個案或家屬共同討論減少或排除疼痛的方法。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 子宮肌瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-M01 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 6/13 |

- (5) 評估個案使用疼痛控制方法的意願，在個案選擇疼痛控制方法時，如止痛劑、止痛藥、自控式止痛等，應給予教導與支持。
- (6) 教導個案疼痛時採取舒適的臥位，如側臥、半坐臥、軀體彎曲位或端坐臥勢。
- (7) 鼓勵個案運用熱敷、按摩背部及休息來緩解疼痛的不適感。
- (8) 教導個案放鬆技巧或轉移注意力，如漸進式肌肉放鬆法、按摩、聽音樂、看電視、散步、閱書、聊天，以減緩疼痛。
- (9) 教導咳嗽或改變姿勢時，以手或束腹帶固定傷口。
- (10) 避免腹部用力，如哭鬧蹲姿、用力解便、咳嗽，預防傷口疼痛或裂開。
- (11) 多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減緩疼痛。

### 3. 易感染/與手術後傷口、引流管留存有關

- (1) 每班監測傷口滲出液之顏色、氣味、濃稠度及癒合情況。
- (2) 每班監測引流液之量、顏色、氣味、性質及周圍皮膚之完整性。
- (3) 監測可顯示感染的實驗室檢查，並報告異常現象。
- (4) 教導個案或主要照顧者炎症症狀，如紅、腫、熱、痛及徵象，如發燒、流膿，若有以上之情形應通知醫護人員。
- (5) 教導個案或主要照顧者引流管勿高於放置或穿刺部位，維持引流管之通暢，並教導及協助翻身或活動方式，避免壓迫引流管。
- (6) 教導個案或主要照顧者預防感染的方法，如接觸個案前洗手、保持傷口清潔及乾燥、避免壓迫傷口、注意衛生、營養充足等，並評估其瞭解程度。
- (7) 視需要更換敷料，保持傷口清潔及乾燥。
- (8) 若個案情況許可，與醫師討論儘早拔除侵入性治療的管路，以預防感染的發生。
- (9) 建議採少量多餐，以增進食量，必要時依醫囑給予維他命、營養素或適量輸液。
- (10) 評估個案營養狀況，給予飲食衛教。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 子宮肌瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-M01 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 7/13 |

#### 4. 身體心像不一致/與子宮切除導致身體完整性受損有關

- (1) 以主動傾聽、開放式問題，鼓勵個案表達感受。
- (2) 以不批判態度接受個案用憤怒來表達自己的挫折或感受。
- (3) 若個案陳述的感受消極、負向且不正確，應適時給予澄清或修正。
- (4) 給予個案足夠的時間，讓個案接受失去的子宮的事實。
- (5) 以溫和漸進方式，鼓勵個案去觸摸及正視手術的傷口。
- (6) 醫師換藥時在旁陪伴，告知傷口情形，鼓勵其注視傷口，給予情緒支持如：  
可握住個案雙手等。
- (7) 當個案開始接受失去子宮的事實且情緒正向時，應給予鼓勵。
- (8) 隨時給予精神支持，幫助個案瞭解自己的長處，促進其整體感受，抵消因  
身體心像改變造成的恐懼。
- (9) 鼓勵個案走出病房，多接觸其它人、事、物，找尋適當方法抒解情緒。
- (10) 介紹相同個案，互相表達感受，彼此交換意見。
- (11) 鼓勵個案習慣別人的眼光，正向的將別人的眼光視為關懷。
- (12) 若發現個案有退縮及拒絕的行為，應瞭解原因並協助解決。
- (13) 讓個案瞭解疾病過程及疾病對外觀上的改變，如：利用圖片、相片以澄清  
疑慮。
- (14) 與個案討論並列出失去子宮、輸卵管、卵巢對正常社交生活影響的範圍及  
因素。
- (15) 個案若有虔誠的宗教信仰，鼓勵可適當的應用，避免負向情緒。
- (16) 協助個案的親人（先生）接受個案失去子宮的事實，常表達關懷，給予安  
全感。

#### 5. 性生活型態/與子宮切除術後有關

- (1) 主動了解與尊重的態度接受個案對性問題的感受及想法。
- (2) 鼓勵個案與配偶（性伴侶）表達性困擾及性相關的焦慮情緒。
- (3) 完整評估個案性生活形態、性活動頻率、性功能障礙的情況。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 子宮肌瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-M01 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 8/13 |

- (4) 了解個案對性困擾所產生之性偏見，釐清性問題發生的導因，協助矯正。
- (5) 協助個案與配偶（性伴侶）雙向溝通，建立良好互動，減少性生活恢復過程的壓力。
- (6) 提供書面、衛教單張、錄影帶，待個案與配偶閱閉後，再與個案及配偶（性伴侶）討論，提供正確的性知識，以增強個案與配偶（性伴侶）學習性生活調適之能力。
- (7) 鼓勵個案與配偶（性伴侶）共同參與衛教與性諮商過程。
- (8) 個案呈現情緒障礙或焦慮反應時，應終止會談，並適時提供有力的心理支持，建立性生活的信心，並增強正向的自我概念。
- (9) 衛教個案與配偶（性伴侶）性生活，包括口交、擁抱、親吻、愛撫、自慰、共同沐浴、按摩敏感地帶等，可以透過這些活動一樣可獲得性滿足。
- (10) 當個案出現需要醫療處置之潛在或現存的性問題時，給予適當轉介，如性諮商與行為治療。

## （七）衛教指導

### 1. 飲食方面

- (1) 一般而言，採腹腔鏡手術於手術後，視醫囑禁食 8 小時；開腹手術視醫囑禁食至排氣，或有腸蠕動時，依醫囑可進食。
- (2) 可以開始進食時，應先喝白開水約 30-50c.c.，若無噁心、嘔吐腹脹、腹痛、腸絞痛後，可吃白飯、新鮮自烹白稀飯、麵條等軟質飲食，勿吃太快太多，避免腸絞痛。沒有任何不適時，可以恢復正常飲食，採少量多餐，不要太油膩及太鹹。
- (3) 建議個案 1 週內少攝取刺激性食物如辣椒、咖啡；少進食易產氣食物如牛奶、蛋、豆類製品、地瓜、麵包等，以防腹脹不適；增加水份攝取，以避免便秘；建議 2 週內避免進食含人參、麻油、酒等食物，避免影響傷口癒合。

### 2. 傷口方面

- (1) 衛教腹腔鏡手術後腹部可能有 2-4 個小傷口，或是開腹手術後會有 1 個約

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 子宮肌瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-M01 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 9/13 |

10-15 公分橫式或直式傷口，且必要時醫師有可能會放置傷口引流管，可能會引起身體不適。

- (2)每班觀察傷口有無紅、腫、熱、痛，或不正常的分泌物及傷口恢復狀況。
- (3)手術後當天不會換藥，手術後第三天會由醫師換藥，之後每 2 天換藥一次，或視當時傷口情況換藥。
- (4)換藥步驟及方法：將無菌食鹽水滴至無菌棉棒，以傷口為中心點，由內向外塗擦清潔至傷口周圍外至少 5 公分處，再將無刺激性優點藥水滴至無菌棉棒塗擦消毒，約停留 20-30 秒，最後再使用無菌食鹽水將優點藥水擦去，消毒完畢後再以無菌紗布或無菌敷料覆蓋傷口及黏貼好。
- (5)教導個案需保持傷口及周圍皮膚清潔與乾燥。
- (6)教導腹部傷口約 10-14 天癒合，需保持清潔乾燥。
- (7)出院後建議傷口約 2-3 天換藥，或是不小心弄濕或滲濕時應更換之。

### 3.傷口疼痛方面

- (1)教導在傷口換藥後或下床時使用束腹帶，減少腹部傷口牽扯，減輕傷口疼痛。
- (2)衛教 4-6 週內避免提重物，若需提 5 公斤以上重物時，建議可使用束腹帶固定傷口，以避免疼痛。

### 4.活動方面

- (1)衛教手術後當天在床上應多翻身或側臥，最好每 2 小時翻身一次，促進血液循環，增加腸蠕動，以預防腸道粘連，並鼓勵個案早期下床活動。
- (2)手術後第二天盡可能採漸進式下床活動，可以先採半坐臥，若未感不適則可以採坐臥，再坐於床邊，慢慢站起走動，全程需由家屬或朋友陪伴，以防止跌倒之虞。
- (3)避免長時間坐或站、勿激烈運動，如機車、騎腳踏車、開車長途旅行、爬山、游泳。

|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 子宮肌瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-M01 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 10/13 |

## 5. 衛生方面

- (1)手術後導尿管會留置大約 1 天，導尿管留置期間會給予會陰沖洗及導尿管的護理，並視情況協助移除導尿管。移除尿管後，需注意第一次解尿時間（4-6 小時內自解）及記錄排尿量與觀察尿液顏色。
- (2)手術後若陰道有血狀排泄物，應勤換產墊或棉墊，以保持乾淨，避免感染。
- (3)如廁後衛生紙應由前往後擦拭，勤換棉墊，避免感染。
- (4)個案身體清潔之照護，手術後先以擦拭方式為主，醫師會視傷口癒合狀況，評估是否可以開始沐浴。若可以沐浴時，建議宜採淋浴方式，勿盆浴及陰道灌洗，以避免傷口感染。

6. 性方面：需在醫師診察傷口癒合後，視情況約 2-6 週可恢復性生活。

## 7. 其他方面

- (1)跟個案衛教術後會有助骨及肩部酸痛不適情形，約會持續 2-3 天。
- (2)出院後若有以下情形應立即回診：傷口有紅、腫、熱、痛及滲出液情形；體溫 $>38^{\circ}\text{C}$  以上；解尿困難、疼痛、頻尿、有灼熱感；陰道出血量多呈鮮紅色、惡臭。

## （八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

## 四、使用表單

（略）

## 五、流程圖

（略）

|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 子宮肌瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-M01 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 11/13 |

## 六、參考資料

- (一) 吳志宏、陳世杰(2025)・高強度聚焦超音波未來的應用・台灣醫學，29(2)，189-195。
- (二) 莊博涵、陳世杰(2025)・磁振導引高能聚焦超音波在婦產科的應用・台灣醫學，29(2)，196-201。
- (三) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、孫瑞瓊、林淑玲、黃樹欽、陳怡靜、徐莞雲(2020)・產科護理學(十版)・台北：新文京。
- (四) 潘以如(2025)・經子宮動脈栓塞術及腹腔鏡全子宮切除治療的巨大左側漿膜下子宮肌瘤的案例報告・秀傳醫學雜誌，24(1)，67-73。

## 七、附件

(略)

|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 子宮肌瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-M01 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 12/13 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期       | 版本  | 修正說明                                                                      | 備註                          |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 97.05.31   | 1.0 | 新制定                                                                       | 97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過  |
| 99.08.31   | 2.0 | 配合本院 SOP 格式改版                                                             |                             |
| 100.08.31  | 2.1 | 修改說明內容與錯別字                                                                | 100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過 |
| 101.08.31  | 2.2 | 醫護部改護理部                                                                   | 101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過 |
| 102.02.08  | 3.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱                                                |                             |
| 102.08.31  | 3.1 | 說明內容部份修辭                                                                  | 102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過 |
| 103.06.30  | 3.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                           |                             |
| 104.02.03  | 3.2 | 更新第六項參考資料內容                                                               | 104 年 02 月 03 日護理部照護標準委員會通過 |
| 104.08.31. | 3.3 | 1.第三項第(一)目部份內容刪修<br>2.更新第六項文獻參考資料                                         | 104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過 |
| 105.08.31  | 3.4 | 1. 第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。<br>2. 新增第三項第(四)目之 2(7)、(8)之內容。<br>3. 第六項文獻參考資料更新 | 105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過 |
| 106.08.31  | 3.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                           |                             |
| 107.06.29  | 3.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                           |                             |
| 107.09.12  | 3.5 | 第三項第七目之 1(2)內容修訂。                                                         | 107 年 09 月 12 日護理長會議通過      |

|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 子宮肌瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-M01 | 版本   | 第 3.9 版 | 頁碼/總頁數 | 13/13 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                 | 備註                                                                       |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 108.09.23 | 3.6 | 1. 第二項新增（含中興分院）。<br>2. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 | 108 年 09 月 11 日照護標準組會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。                        |
| 109.08.18 | 3.7 | 1. 新增參考文獻出處於內文中。<br>2. 第六項參考資料修訂。                                    | 109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。 |
| 110.08.05 | 3.7 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                          |
| 111.09.06 | 3.8 | 1. 第三項第五、六目之護理問題名稱修訂。<br>2. 第六項參考資料修訂。<br>3. 刪除內文參考文獻。               | 111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。 |
| 112.08.03 | 3.8 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                          |
| 113.08.08 | 3.8 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                      |                                                                          |
| 114.10.08 | 3.9 | 修訂第六項參考文獻資料。                                                         | 114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。 |
|           |     |                                                                      |                                                                          |
|           |     |                                                                      |                                                                          |
|           |     |                                                                      |                                                                          |